

ANTAGONISTES DES RECEPTEURS DE L'ALDOSTERONE

Spironolactone / éplérénone

Mode d'action du médicament

Ces diurétiques inhibent la réabsorption de sodium au niveau du tube contourné distal et du tube collecteur du néphron (cf. schéma diurétiques de l'anse).

Ce sont des inhibiteurs compétitifs de l'aldostérone. Ils inhibent la réabsorption du sodium en échange du potassium induite par l'aldostérone. Ceci favorise la rétention de potassium.

Les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone ont une similarité structurale avec les stéroïdes sexuels. Par rapport à la spironolactone, l'éplérénone présente une affinité plus élevée pour les récepteurs minéralocorticoïdes et plus faible pour les récepteurs aux androgènes et à la progestérone.

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés.

Indications principales

Les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone sont utilisés dans l'hyperaldostéronisme primaire et secondaire (insuffisance cardiaque, cirrhose hépatique).

Spironolactone

- Hyperaldostéronisme primaire
- Insuffisance cardiaque: réduit la mortalité (NNT = 10) et la morbidité cardiovasculaire dans l'IC systolique grave (NYHA III-IV).
- Cirrhose avec ascite
- Syndrome néphrotique : lorsque les mesures usuelles, telles que la restriction d'eau et de sel, ainsi que les diurétiques classiques, ne donnent pas le résultat escompté
- Hypertension : conjointement à d'autres antihypertenseurs lorsque les mesures usuelles ne donnent pas les résultats escomptés ou produisent des effets indésirables.

Eplérénone

- En complément à un traitement standard incluant les bêta-bloquants, pour réduire le risque de mortalité et de morbidité cardiovasculaires chez le patient stable présentant une dysfonction ventriculaire gauche (FEVG $\leq 40\%$) et des signes cliniques d'insuffisance cardiaque après un infarctus du myocarde récent.

Caractéristiques pharmacocinétiques

Spironolactone : métabolisme hépatique en métabolites actifs, excrétés principalement par les reins. Demi-vie de la molécule mère : ~ 1h, des métabolites : 10-20h

Eplérénone : est métabolisée au niveau hépatique par les CYP3A4. Les métabolites ne sont pas actifs. La demi-vie est de 4-6h.

Effets indésirables

type A

- Hyperkaliémie.
NB: suite à l'étude RALES, la prescription à très large échelle de la spironolactone dans l'IC a résulté en une épidémie d'hyperkaliémies graves. Son emploi n'est donc recommandé qu'en 2^{ème} ligne en cas d'IC sévère malgré un traitement optimal d'IEC, bêtabloquants et diurétiques de l'anse. En présence d'une insuffisance rénale modérée ou d'une kaliémie > 5.0, les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone doivent être évités.
- Gynécomastie.
- Impuissance sexuelle, règles irrégulières ou aménorrhée, saignements post-ménopausiques.
- Troubles de la fonction rénale.

Interactions médicamenteuses

Interactions pharmacocinétiques:

AINS, ciclosporine et tacrolimus peuvent entraîner une altération de la fonction rénale et majorer le risque d'hyperkaliémie.

Les inhibiteurs du CYP3A4 diminuent la clairance hépatique de l'éplérénone.

Les inducteurs du CYP3A4 augmentent la clairance hépatique de l'éplérénone.

la spironolactone et l'éplérénone provoquent une prolongation de la demi-vie de la digoxine. Il faut diminuer la posologie de la digoxine, probablement par inhibition de la P-glycoprotéine. Il faut diminuer la posologie de la digoxine et effectuer un suivi thérapeutique.

Interactions pharmacodynamiques:

L'association de spironolactone ou d'éplérénone et des diurétiques d'épargne potassique (amiloride, triamtérène), des médicaments à base de potassium ou des sels de régime contenant du potassium, des IEC, des ARA augmente le risque d'hyperkaliémie.

Remarques pour la pratique

Doses de départ:

Spirolactone: 25 mg par jour ou par 2 jours. Dose-cible 25 à 50 mg/j

Eplérénone: 25 mg par jour. Dose-cible 50 mg/j.

La kaliémie doit être mesurée avant l'initiation du traitement, pendant la première semaine de traitement, puis un mois après le début du traitement ou après un ajustement de la posologie. Par la suite, la kaliémie sera contrôlée périodiquement selon les besoins.

Eviter les autres médicaments d'épargne du potassium !

Signaler aux patients qu'ils doivent vous informer avant de prendre des vitamines ou tous suppléments minéraux qui peuvent contenir du potassium (en particulier les sels de substitution pour "régime sans sel").

En 2018, le prix public de l'éplérénone en Suisse est environ 6 fois plus élevé que celui de la spironolactone

Pour en savoir plus

Muller O. et al. Les antagonistes du récepteur minéralocorticoïde. Rev Med Suisse 2007 ; 3 ; 32315

Accès libre : <https://www.revmed.ch/RMS/2007/RMS-113/32315>